

a12_consult 测试报告

生成时间：2026-05-18 15:12:32

测试时间：2026-05-18 15:12:32

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1479 markers=15

禁用工具 success=True chars=1505 markers=15

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

****精神科远程会诊记录****

****会诊日期****：2026年4月19日

****参会人员****：

****问题摘要****：

陈萍忠老人于返院一周内整体状态平稳，BPSD（精神行为症状）持续缓解，NPI评分为15分，仅发生1次轻微事件且干预有效。生命体征及血压血脂控制良好，照护团队结合其喜爱跳舞的特点实施个性化干预，家属焦虑情绪一度有所缓解。然而，近2天（返院第6、7天）出现新发健康异常：老人在活动区自主练习跳舞时，偶发短暂记忆空白，表现为突然忘记舞步、停顿发呆，持续约1-2分钟后自行恢复，恢复后无躯体不适，但情绪略显低落，并拒绝与其他老人共同跳舞或交流。家属探视时观察到该现象，担忧其认知功能加速衰退，并忧虑此症状可能诱发BPSD复发，导致原本缓解的焦虑情绪再次加重，多次向照护团队咨询认知状态评估及复发预防措施。

****会诊结论****：

结合当前表现，老人新出现的短暂记忆空白、情绪低落及社交退缩，符合阿尔茨海默病性痴呆（病程6年）背景下可能出现的轻度认知波动或情境性失神发作，尚不构成明确的BPSD急性复发（如激越、妄想、攻击等）。但此类认知-情绪变化属于BPSD复发的高危预警信号，尤其在既往存在BPSD史、康复依从性偏低及家属高度焦虑的背景下，需高度重视。当前状态提示疾病可能处于亚临床波动期，亟需加强监测与预防性干预，以阻断向典型BPSD发展的路径。

****药物调整建议**：**

目前老人服用多奈哌齐、美金刚等认知障碍治疗药物及瑞舒伐他汀等慢性病用药，方案合理，符合诊疗指南。近期无新增精神科药物使用指征，亦无药物不良反应报告。****建议维持现有药物方案不变****，暂无需调整剂量或增减药物种类。

****非药物干预建议**：**

1. ****优化认知刺激活动****：将跳舞活动结构化、简化步骤，避免复杂编排引发挫败感；可安排一对一陪伴练习，减少社交压力，逐步重建信心。
2. ****情绪支持与行为引导****：当老人出现停顿发呆后情绪低落时，照护员应温和陪伴，避免追问或催促，采用转移注意力策略（如播放其喜爱的音乐、引导至安静区域休息）。
3. ****家属沟通与心理支持****：安排专人定期向家属反馈老人认知与情绪动态，解释当前症状的性质与预后，减轻其过度担忧；提供BPSD早期识别手册，增强家庭应对能力。
4. ****环境安全强化****：虽当前跌倒防护到位，仍需警惕因短暂失神导致的平衡失调，确保活动区地面防滑、无障碍物。

****后续观察重点**：**

- 记忆空白发作的频率、持续时间及诱因（如疲劳、噪音、特定动作）；
- 情绪低落是否持续或加重，有无兴趣减退、睡眠食欲改变；
- 社交回避行为是否扩展至其他日常互动场景；
- 是否出现新的BPSD征兆（如言语混乱、猜疑、游走、夜间躁动等）。

****下次复诊时间****：2026年4月26日（1周后）

****待执行事项**：**

1

【禁用工具输出摘录】

****精神科远程会诊记录****

****会诊日期****：2025年4月4日

****参会人员****：（未提供，留空）

****问题摘要**：**

陈萍忠老人返院一周内整体状态平稳，BPSD症状持续缓解，期间仅发生1次轻微行为心理症状（BPSD），经干预后未再复发，当前NPI评分为15分；生命体征稳定，血压血脂控制良好，照护措施落实到位，尤其在跌倒防护、规范用药及BPSD干预方面表现突出。照护团队结合其喜爱跳舞的兴趣开展个性化非药物干预，家属焦虑情绪曾有所缓解。然而，近2天（返院第6、7天）出现新发健康异常：老人在自主练习跳舞时偶发短暂记忆空白，表现为突然忘记舞步、停顿发呆，持续约1-2分钟后自行恢复，恢复后无躯体不适，但情绪略显低落，并拒绝与其他老人共同跳舞或交流。家属探视时观察到该现象，担忧其认知功能进一步下降，并忧虑可能诱发BPSD症状复发，原有焦虑情绪明显反复，多次向照护团队咨询认知状态及复发风险，请求专业干预。

****会诊结论**：**

当前新发症状（短暂记忆空白、情境性发呆、情绪低落、社交退缩）尚不构成典型BPSD复发，亦无谵妄或精神病性症状表现，但提示可能存在轻度认知波动或早期神经认知功能变化，属于BPSD复发的潜在预警信号。需警惕情绪低落与社交回避对整体功能的负面影响，并高度关注家属焦虑情绪对照护协同的干扰。

****药物调整建议**：**

鉴于目前BPSD症状控制良好、无新增精神行为紊乱（如激越、攻击、幻觉、妄想等），且新发症状以认知-情绪表现为主，无明确药物干预指征，建议****维持现有精神科用药方案不变***，暂不新增或调整抗精神病药、抗抑郁药或镇静类药物。

****非药物干预建议**：**

1. ****结构化认知-运动干预****：将老人喜爱的跳舞活动调整为结构化、小步骤、有引导的团体舞蹈课程，避免独自练习引发挫败感；可加入音乐回忆疗法元素，增强熟悉感与成功体验。
2. ****情绪支持与社交促进****：安排固定陪伴员在活动时段给予温和鼓励，采用非评判性语言重建其参与信心；逐步引导其与1-2位相熟老人进行低压力互动。
3. ****家属沟通与心理支持****：组织一次专项家属沟通会，由精神科医生或照护主管解释当前症状性质（非急性恶化，但需监测），提供BPSD复发预警清单，指导家属如何在家访时给予积极反馈而非过度追问，减轻其焦虑。
4. ****环境优化****：确保活动区光线充足、标识清晰，减少因环境混乱导致的认知负荷。

****后续观察重点**：**

- 记忆空白发作频率、持续时间及诱因（如疲劳、噪音、陌生环境）；
- 情绪状态变化（是否出现持续低落、哭泣、自责）；
- 社交参与意愿及BPSD相关行为（如激越、游走、重复言语、妄想）；
- 日常生活功能是否出现新下降（如穿衣、进食、如厕）。

****下次复诊时间****：2025年4月18日（2周后）

*